

Pneumonia comunitária

PAC

Confirmar o diagnóstico, estratificar a gravidade, escolher o local de cuidado e iniciar o antibiótico certo sem atraso.

Suspeita clínica

Tosse, febre, dispneia, dor pleurítica, taquipneia ou achado focal. Ausência de febre não exclui.

Imagem

Infiltrado novo na radiografia. Ultrassom pulmonar é alternativa onde há competência técnica (ATS 2025).

Oximetria sempre

Hipoxemia pesa na decisão de internar, mesmo com escore baixo.

Microbiologia

Hemoculturas e escarro na PAC grave ou com risco de MRSA/Pseudomonas, sem atrasar o antibiótico.

Estratificar e decidir o local

Escore apoia, não substitui, o julgamento clínico

CURB-65 (1 ponto cada)

Letra	Critério
C	Confusão mental nova
U	Ureia > 50 mg/dL (figura SBPT 2018; original > 7 mmol/L)
R	Frequência respiratória ≥ 30/min
B	PAS < 90 ou PAD ≤ 60 mmHg
65	Idade ≥ 65 anos

Pontos	Conduta sugerida
0–1	Possível tratamento ambulatorial
2	Considerar internação ou observação
≥ 3	Alto risco: internar e avaliar UTI

CRB-65 (sem ureia, 0–4) serve para triagem na APS. A ATS/IDSA prefere o PSI. Hipoxemia, intolerância à via oral, comorbidade descompensada ou falta de apoio social contraindicam a alta mesmo com escore baixo.

PAC grave (ATS/IDSA 2019). Um critério maior (ventilação mecânica invasiva ou choque séptico com vasopressor) ou ≥3 menores: FR ≥30; PaO₂/FiO₂ ≤250; infiltrado multilobar; confusão; BUN ≥20 mg/dL; leucócitos <4.000; plaquetas <100.000; temperatura <36 °C; hipotensão que exige volume agressivo.

Antibioticoterapia inicial

Adulto imunocompetente, função renal normal

Cenário	Esquema (ATS/IDSA 2019)
Ambulatório sem comorbidade	Amoxicilina 1 g VO 8/8 h, <i>ou</i> doxiciclina 100 mg VO 12/12 h
Ambulatório com comorbidade cardíaca, pulmonar, hepática ou renal crônica, DM, alcoolismo, neoplasia, asplenia	Amoxicilina-clavulanato 875/125 mg VO 12/12 h (ou cefuroxima 500 mg 12/12 h) + azitromicina 500 mg no 1º dia e 250 mg/dia (ou doxiciclina); <i>ou</i> levofloxacino 750 mg/dia ou moxifloxacino 400 mg/dia
Enfermaria	Ceftriaxona 1–2 g IV/dia (ou ampicilina-sulbactam 1,5–3 g 6/6 h) + azitromicina 500 mg/dia; <i>ou</i> fluoroquinolona respiratória isolada
PAC grave / UTI	Betalactâmico + macrolídeo (preferência ERS 2023) ou betalactâmico + fluoroquinolona
Risco de MRSA ou Pseudomonas	Cobertura dirigida só com fator de risco individual ou ecologia local; culturas e descalonamento em 48–72 h

No Brasil, evite macrolídeo em monoterapia. A ATS/IDSA só o aceita com resistência pneumocócica local <25%; na vigilância SIREVA/IAL de isolados invasivos (2018–2023), a resistência à eritromicina foi de 46,1%.

Duração, corticoide e influenza

Duração: em geral 5–7 dias, guiada pela estabilidade clínica; ≥5 dias na PAC grave. A ATS 2025 admite 3 dias apenas em PAC não grave, estável e com seguimento. **Corticoide:** sugerido na PAC grave (exceto por influenza); não usar na não grave. **Influenza com SRAG ou fator de risco:** oseltamivir 75 mg VO 12/12 h por 5 dias, sem aguardar confirmação.

Reavaliar em 48–72 h

Oxigenação, hemodinâmica, estado mental, via oral, culturas e efeitos adversos. Falha pede busca de derrame ou empiema, abscesso, obstrução, resistência ou diagnóstico alternativo, e não só troca de antibiótico. Ajustar doses à função renal, alergias e antibiograma local.

Fontes: Corrêa RA et al. SBPT 2018, J Bras Pneumol. 2018;44:405-423; Metlay JP et al. ATS/IDSA 2019, AJRCCM. 2019;200:e45-e67; Martin-Loeches I et al. ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2023, Eur Respir J. 2023;61:2200735; ATS CPG 2025, AJRCCM. 2026;212:24-44; SIREVA II/IAL-NMPI 2018–2023. Lista completa em referencias.txt.